

SHOULDER DISLOCATION

خلع الكتف

د. علي طارق جاسم | Dr. Ali Tariq Jassim

1. INTRODUCTION & ANATOMY | مقدمة وتشريح

Learning Objectives

- Describe the anatomy
- Classify shoulder dislocations
- Recognize clinical and radiographic findings
- Outline reduction and indications for surgery
- Identify important complications

الأهداف التعليمية

وصف التشريح

تصنيف خلوع الكتف

التعرف على العلامات السريرية والشعاعية

توضيح طرق الرد (الإرجاع) ودواعي الجراحة

تحديد المضاعفات المهمة

Shoulder Anatomy

تشريح الكتف

- Glenohumeral joint:** humeral head articulates with glenoid
المفصل العضدي الحقاني: يتمفصل رأس عظم العضد مع التجويف الحقاني
- Static stabilizers:** labrum, capsule, glenohumeral ligaments
المثبتات الساكنة: الشفة الحقانية، المحفظة، الأربطة العضدية الحقانية
- Dynamic stabilizers:** rotator cuff and scapular muscles
المثبتات الديناميكية: الكفة المدورة وعضلات لوح الكتف
- Large humeral head with relatively shallow glenoid allows extensive motion
رأس العضد الكبير مع التجويف الحقاني الضحل نسبياً يسمح بحركة واسعة

2. CLASSIFICATION & TYPES | التصنيف والأنواع

Classification

التصنيف

- **Anterior:** most common 95 %
- **Posterior:** uncommon and frequently missed
- **Inferior:** rare; luxatio erecta

الأمامي: الأكثر شيوعاً 95%

الخلفي: غير شائع وكثيراً ما يُغفل عن تشخيصه

السفلي: نادر؛ الخلع المنتصب (Luxatio erecta)

Anterior Dislocation

الخلع الأمامي

- Usually caused by abduction + external rotation
- Humeral head moves anterior/inferior to the glenoid
- Common mechanisms: fall, sports injury, direct trauma

يحدث عادةً بسبب التباعد + الدوران الخارجي

يتحرك رأس العضد إلى الأمام/الأسفل من التجويف الحقاني

الآليات الشائعة: السقوط، الإصابات الرياضية، الرض المباشر

Posterior Dislocation

الخلع الخلفي

- Often follows seizures, electrical shock, or significant trauma
- Arm is typically held in adduction and internal rotation
- AP radiograph may be misleading; axillary or scapular-Y view is important

غالباً ما يعقب نوبات الصرع، أو الصدمة الكهربائية، أو الرضوض الشديدة

يكون الذراع عادةً في وضع التقريب والدوران الداخلي

قد تكون الصورة الشعاعية الأمامية الخلفية (AP) مضللة؛ لذا فإن المنظر الإبطي أو منظر Y للوح الكتف مهم

Inferior Dislocation – Luxatio Erecta

الخلع السفلي – الخلع المنتصب

- Usually results from forced hyperabduction
- High risk of associated neurovascular and soft-tissue injury

ينتج عادةً عن فرط التباعد القسري

خطر عالٍ لإصابة مرافقة في الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة الرخوة

3. CLINICAL ASSESSMENT & IMAGING | التقييم السريري والتصوير

Clinical Presentation

العرض السريري

- Severe shoulder pain and inability to move the arm
ألم شديد في الكتف وعدم القدرة على تحريك الذراع
- Visible deformity may be present with flattening of lateral shoulder
قد يوجد تشوه مرئي مع تسطح الجزء الجانبي من الكتف
- Patient often supports the affected arm
غالباً ما يسند المريض الذراع المصابة

Neurovascular Examination

الفحص العصبي الوعائي

- Document before and after reduction
يجب التوثيق قبل الرد وبعده
- Check axillary nerve: sensation over lateral shoulder and deltoid function
فحص العصب الإبطي: الإحساس فوق الجزء الجانبي للكتف ووظيفة العضلة الدالية
- Assess radial pulse and distal perfusion
تقييم النبض الكعبري والتروية الطرفية
- Document motor and sensory function of the entire limb when appropriate
توثيق الوظيفة الحركية والحسية للطرف بأكمله عند الحاجة

Imaging

التصوير

- **X-RAY:** AP plus axillary or scapular-Y views improve characterization
الأشعة السينية: المنظر الأمامي الخلفي (AP) مع المنظر الإبطي أو منظر Y للوح الكتف يحسّن توصيف الإصابة
- **CT:** complex fracture/dislocation
الأشعة المقطعية (CT): الكسر/الخلع المعقد
- **MRI:** selected soft-tissue/labral or rotator-cuff assessment
الرنين المغناطيسي (MRI): تقييم حالات مختارة للأنسجة الرخوة/الشفة الحقانية أو الكفة المدورة

Associated Injuries

الإصابات المرافقة

- **Bankart lesion:** labral injury
آفة بانكارت (Bankart): إصابة الشفة الحقانية
- **Hill-Sachs lesion:** humeral-head impaction
آفة هيل-ساكس (Hill-Sachs): انضغاط (انطمار) في رأس العضد
- Greater tuberosity fracture
كسر الحدة الكبرى

- Rotator-cuff injury, especially in older patients

إصابة الكفة المدورة، خاصةً لدى المرضى الأكبر سناً

- Axillary nerve or vascular injury

إصابة العصب الإبطي أو إصابة وعائية

4. MANAGEMENT & COMPLICATIONS | العلاج والمضاعفات

Initial Management

العلاج الأولي

After general assessment and appropriate analgesia:

بعد التقييم العام وإعطاء المسكنات المناسبة:

- Hippocrates technique – anterior shoulder closed reduction (تقنية أبقرط - الرد المغلق لخلع الكتف الأمامي)
- Kocher's method (طريقة كوخر)

Surgical Indications

دواعي الجراحة

- Recurrent instability
- Significant bone loss
- Selected Bankart/labral injuries
- Fracture-dislocation requiring fixation
- Failure of appropriate nonoperative management

عدم الثبات المتكرر

فقدان عظمي كبير

حالات مختارة من إصابات بانكارت/الشفة الحقانية

الكسر-الخلع الذي يتطلب تثبيتاً

فشل العلاج غير الجراحي المناسب

Complications

المضاعفات

- Recurrent dislocation/instability
- Axillary nerve injury
- Fracture or fracture-dislocation
- Rotator-cuff injury
- Post-traumatic stiffness

الخلع المتكرر/عدم الثبات

إصابة العصب الإبطي

الكسر أو الكسر-الخلع

إصابة الكفة المدورة

التيبس ما بعد الرض

Case Discussion

مناقشة حالة

Young athlete falls during contact sport with arm abducted and externally rotated.

رياضي شاب يسقط أثناء رياضة احتكاكية وذراعه في وضع التباعد والدوران الخارجي.

Examination: painful deformity and limited movement.

الفحص: تشوه مؤلم ومحدودية في الحركة.

Questions (الأسئلة)

- What is the likely direction?
- What views are needed?
- What must be documented before reduction?
- What associated lesions should be considered?

ما هو الاتجاه المرجح للخلع؟

ما هي المناظر الشعاعية المطلوبة؟

ما الذي يجب توثيقه قبل الرد؟

ما هي الآفات المرافقة التي يجب أخذها بالاعتبار؟